



Transtornos Cognitivos e Demências

Da avaliação ao tratamento:
evidências, raciocínio clínico
e cuidado centrado na pessoa

INTERNATO | SAÚDE DO IDOSO



Aprender ativamente. Pensar criticamente. Cuidar melhor.

Objetivos da aula



O que o aluno do 1º ano deve levar para a prática e para a prova.

OBJETIVOS

Entender

a diferença entre
síndrome, nosologia
e etiologia

Investigar

com anamnese, exame,
neuropsicologia, imagem
e laboratório

Diferenciar

Alzheimer, DCL, DFT,
vascular e causas
tratáveis

Tratar

com evidência: fármacos,
reabilitação e cuidado
multidisciplinar

Meta pedagógica: usar casos, perguntas e fluxogramas para transformar conteúdo em raciocínio clínico.

Por que este tema importa?



Mais pacientes, mais diagnósticos precoces e mais decisões complexas no consultório.

≈55 milhões

de pessoas vivem com
demência no mundo

Até 40%

dos casos podem ter
fatores de risco modificáveis

+ biomarcadores

e terapias iniciais mudam
o valor do diagnóstico
precoce

Mensagem central: diagnosticar corretamente é o que separa cuidado banal de cuidado transformador.

No pré-geriátrico, apresentações atípicas e causas tratáveis ganham mais peso

Por que este tema importa?

Mais pacientes, mais diagnósticos precoces e mais decisões complexas no consultório.



SÍNDROMES DEMENCIAIS NA REALIDADE MUNDIAL

EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO GLOBAL



Alzheimer's Disease
International
The global voice on dementia



WORLD
FEDERATION
OF NEUROLOGY

PANORAMA GLOBAL



> 57 milhões
de pessoas vivem com demência
no mundo (2023)



~ 152 milhões
em 2050 (projeção)



1 em cada 11 pessoas
com 65 anos ou mais



Maior crescimento
em países de baixa e média
renda

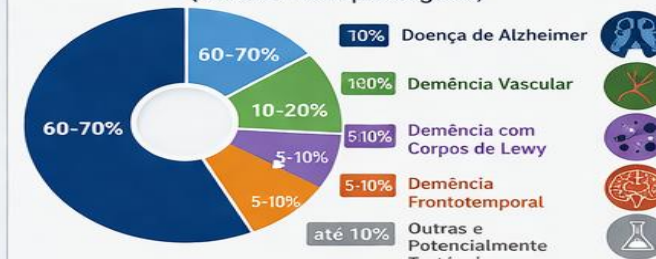
PREVALÊNCIA POR REGIÃO (% da população ≥ 60 anos)

África	4,1%
Américas	7,3%
Mediterrâneo Oriental	6,2%
Europa	7,7%
Sudeste Asiático	4,6%
Pacífico Ocidental	5,5%



Fonte: Alzheimer's Disease International, World Alzheimer Report 2023.

DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS (estudos neuropatológicos)



Fonte: Jellinger KA et al. Acta Neuropathol. 2015;130:1-24.

AS SÍNDROMES DEMENCIAIS EM SUA REALIDADE CLÍNICA (PERFIS SINDRÔMICOS MAIS FREQUENTES)

DOENÇA DE ALZHEIMER

50-70% dos casos

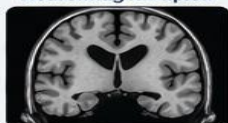


Início insidioso e progressão
lenta.

Predomínio:

- Memória episódica
- Linguagem (anomia)
- Funções visuo-espaciais

Neuroimagem típica



Atrofia do hipocampo
e córtex temporo-parietal

Pistas-chave

- Perda de memória precoce
- Desorientação
- Evolução gradual

DEMÊNCIA VASCULAR

10-20% dos casos

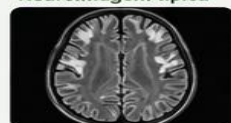


Início por degraus ou súbito.
Relação com AVC e fatores
vasculares.

Predomínio:

- Atenção e funções executivas
- Memória (padrão subcortical)
- Velocidade de processamento

Neuroimagem típica



Lesões na substância branca,
infartos lacunares

Pistas-chave

- História de AVC
- Piora em "degraus"
- Marcha e humor afetados

DEMÊNCIA COM CORPOS DE LEWY

5-10% dos casos

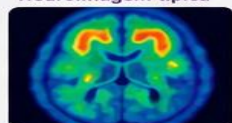


Flutuação cognitiva e atenção
variável.

Predomínio:

- Atenção
- Funções visuais
- Funções executivas

Neuroimagem típica



Redução do metabolismo
occipital (SPECT/PET)

Pistas-chave

- Alucinações visuais
- Parkinsonismo
- Flutuações + RBD

DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL

5-10% dos casos



Início precoce (45-65 anos).
Mudanças de comportamento
e linguagem.

Predomínio:

- Comportamento/social
- Linguagem
- Funções executivas

Neuroimagem típica



Atrofia frontotemporal
(assimétrica possível)

Pistas-chave

- Desinibição/apatia
- Linguagem comprometida
- Memória relativa preservada

DEMÊNCIA NA DOENÇA DE PARKINSON

Frequente em estágios avançados



Complicação não motora.
Piora de funções executivas
e memória.

Predomínio:

- Funções executivas
- Atenção
- Memória (tardia)

Neuroimagem típica



Redução de dopamina
(SPECT/PET)

Pistas-chave

- Parkinsonismo prévio
- Alucinações
- Declínio mais tardio

DEMÊNCIAS POTENCIALMENTE TRATÁVEIS

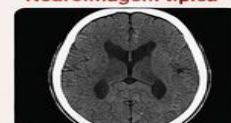
5-10% dos casos



Causas principais:

- Deficiência de B12
- Distúrbios tireoidianos
- Hidrocefalia normotensiva
- Depressão
- Infecções (HIV, sífilis)
- Uso de medicamentos

Neuroimagem típica



Depende da causa
(ex.: ventriculomegalia)

Pistas-chave

- Início subagudo
- Sinais atípicos
- Exames alterados

DEMÊNCIA MISTA FREQUENTE

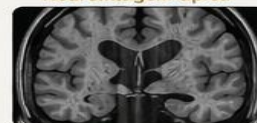
Até 50% dos casos em
idosos muito idosos



Associação de 2 ou mais
etiologias (ex.: Alzheimer +
vascular).

Predomínio: combinado.

Neuroimagem típica



Achados mistos (ex.: atrofia
+ lesões vasculares)

Pistas-chave

- Idade avançada
- Múltiplos fatores de risco
- Padrão clínico misto

Mensagem central: reconhecer padrões sindrômicos + buscar causas tratáveis + integrar clínica, exames e contexto.

Fontes: Alzheimer's Disease International (2023); World Federation of Neurology (2022);
Dubois et al. Lancet Neurol. 2021; McKeith et al. Neurology. 2017.

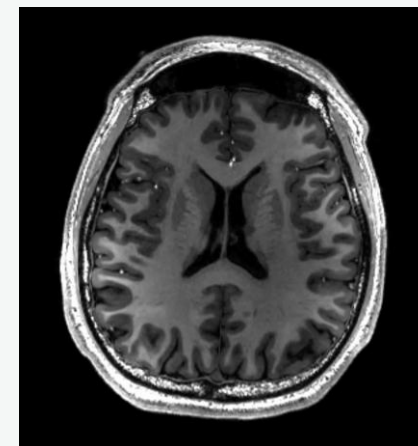
Pergunta disparadora

Metodologia ativa começa com problema, não com resposta.



**Paciente de 72 anos, professora aposentada:
“esqueço contas, repito perguntas e
comecei a errar remédios”.**

- O que diferencia envelhecimento normal de síndrome demencial?
- Qual pergunta inicial tem maior valor clínico?
- Quais hipóteses você não pode perder?
- Que exame pedir primeiro: teste cognitivo, RM ou laboratório?



**Vote antes de avançar.
Depois compare sua
hipótese com o fluxograma
da aula.**

Roteiro da aula



Do primeiro minuto da consulta ao plano terapêutico integrado.



Casos, perguntas e discussões ao longo do caminho.

Conceitos-chave



O mesmo paciente pode ter síndrome, doença clínica e causa biológica diferentes.

Síndrome

conjunto de sinais e
sintomas (ex.: transtorno
neurocognitivo maior)

Nosologia

entidade clínica
(ex.: doença de Alzheimer,
DCL, DFT)

Etiologia

processo causal/biológico
(ex.: amiloidopatia, doença
vascular, autoimune)

Regra de ouro: “demência” é ponto de partida; o alvo é fechar a formulação final em 3 linhas.

Passo a passo no consultório (1)

Quando pensar em síndrome demencial?



- Queixa cognitiva + prejuízo funcional = alerta forte.
- Piora progressiva relatada por informante vale muito.
- Dificuldade recente com finanças, receitas, medicações e direção são “triggers” práticos.
- Mudança de comportamento, repetição de perguntas ou desorientação topográfica aceleram a investigação.

Pergunta inicial de alto valor: “o que ele fazia antes e agora não faz mais?”



Curiosidade clínica: erros financeiros podem anteceder o diagnóstico formal por anos.

Passo a passo no consultório (2)



Anamnese estruturada: paciente + informante.

Checklist mínimo

- início, curso e velocidade de progressão
- domínio afetado primeiro: memória, linguagem, visuoespacial, executivo ou comportamento
- impacto em AIVDs/ABVDs
- humor, sono REM, alucinações, quedas, marcha, incontinência
- medicações, álcool, anticolinérgicos, comorbidades e história familiar

Red flags já na história

- idade <65 anos
- evolução em semanas–meses
- crises epiléticas, cefaleia, febre ou perda ponderal
- alteração comportamental muito precoce
- alucinações visuais complexas + flutuação
- marcha desproporcional à memória

Sem informante, o diagnóstico fica mais frágil.

Passo a passo no consultório (3)



Exame físico, neurológico e estado mental direcionam o diferencial.

- sinais focais → pense vascular, tumor, subdural
- parkinsonismo espontâneo → DCL / Parkinson-demência
- marcha magnética/aprática → HPN
- mioclonias/ataxia → doença priônica ou autoimune
- agrafestesia, apraxia, agnosia → pistas corticais
- hipotensão ortostática/constipação → suporte a sinucleinopatia



Não esqueça: visão, audição, delirium, sono e depressão podem contaminar todo o exame cognitivo.

Passo a passo no consultório (4)



Triagem cognitiva breve: útil, mas nunca suficiente isoladamente.

Instrumento	O que rastreia	Tempo
MEEM	triagem global	5–7 min
MoCA	executivo/visuoespacial	10 min
Teste do relógio	planejamento/visuoespacial	3 min
Fluência verbal	executivo/linguagem	2–3 min

Pérola prática

- teste normal NÃO exclui CCL ou doença inicial
- escolaridade, humor e reserva cognitiva mudam a interpretação
- se a suspeita clínica é alta, avance para avaliação formal

MoCA tende a ser mais sensível para déficits leves; o relógio captura muito do executivo-visuoespacial em pouco tempo.

Passo a passo no consultório (5)



Avaliação neuropsicológica: onde a clínica vira perfil cognitivo.

Domínios que precisam ser descritos

- atenção e velocidade de processamento
- memória episódica: evocação, reconhecimento e pistas
- funções executivas: flexibilidade, inibição, planejamento
- linguagem: nomeação, fluência, repetição, compreensão
- visuoespacial/visuoperceptivo
- cognição social e comportamento, quando houver suspeita frontotemporal

O que o padrão sugere?

- amnésico de armazenamento → Alzheimer típico
- disexecutivo-lento → vascular/subcortical
- visuoespacial + flutuação → DCL
- comportamental/linguístico → DFT / APP

Rastreo ≠ neuropsicologia formal

Passo a passo no consultório (6)



Exames laboratoriais: investigar reversíveis, agravantes e pistas etiológicas.

Pacote inicial defensável

- hemograma
- TSH / $\pm$ T4 livre
- vitamina B12
- glicemia / HbA1c
- função renal e hepática
- sódio, potássio, cálcio
- sorologia para sífilis (contexto)
- HIV quando houver indicação
- folato se apropriado
- urina se delirium / infecção
- toxicologia e autoimune conforme red flags

Quando ampliar?

- início jovem
- curso rápido
- síndrome sistêmica
- convulsões / cefaleia
- suspeita autoimune, infecciosa ou priônica

Laboratório raramente “fecha” a demência; ele evita erro e identifica o que piora a cognição.

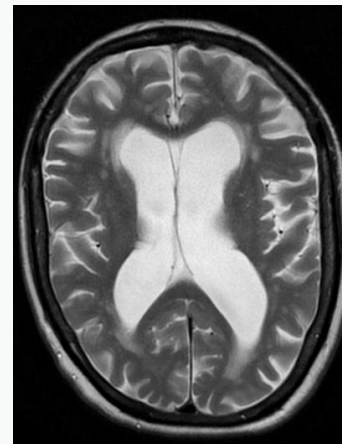
Passo a passo no consultório (7)



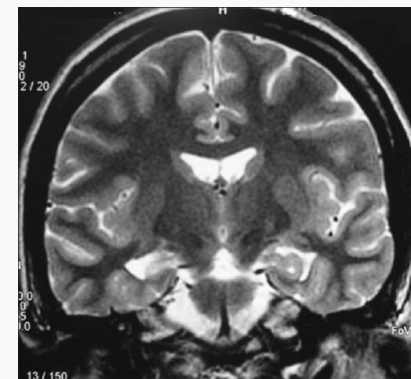
Neuroimagem: o que pedir e por quê?

- RM de encéfalo sem contraste é o exame estrutural inicial preferido na maioria dos casos.
- TC sem contraste é alternativa quando RM não é factível.
- Sequências úteis: T1 3D, T2, FLAIR, DWI, SWI/T2*.
- A imagem exclui mimetizadores e sustenta o subtipo clínico.

Pense em DWI quando o curso for muito rápido; em SWI quando micro-hemorragias importam.



Vascular / ex vacuo



Cortes coronais do
hipocampo

Diagnóstico sindrômico



Primeiro diga se há queixa subjetiva, CCL ou demência.

1

Declínio cognitivo subjetivo

queixa sem comprovação
objetiva consistente

função preservada

2

CCL / MCI

déficit cognitivo
objetivo em ≥ 1 domínio

independência relativa

3

Demência / TNC maior

déficit cognitivo +
prejuízo funcional

impacto em AIVDs/ABVDs

A fronteira prática entre CCL e demência é funcional.

Da síndrome ao diagnóstico final



*Síntese em 3 linhas: **sindrômico** → **nosológico** → **etiológico**.*

Síndrome

ex.: demência leve

Nosologia

ex.: provável doença de
Alzheimer

Etiologia

ex.: processo
neurodegenerativo tipo
Alzheimer; sem causa
alternativa dominante

Exemplo de formulação completa: “TNC maior leve, provável DCL, etiologia sinucleinopática provável, com alucinações visuais, sono REM e parkinsonismo espontâneo”.

Diagnóstico diferencial: visão panorâmica



O padrão inicial costuma ser mais informativo do que o rótulo precoce.

Quadro	Pista clínica dominante
Alzheimer	amnésico progressivo
DCL	flutuação + alucinação visual + REM
DFT	comportamento/língua primeiro
Vascular	executivo-lento + marcha + degraus
HPN	marcha > cognição + urgência
Rápida / secundária	semanas-meses, red flags sistêmicas

Pergunta ativa: se a memória NÃO é o sintoma dominante, o que sobe no seu ranking etiológico?

Pistas clínicas: Doença de Alzheimer

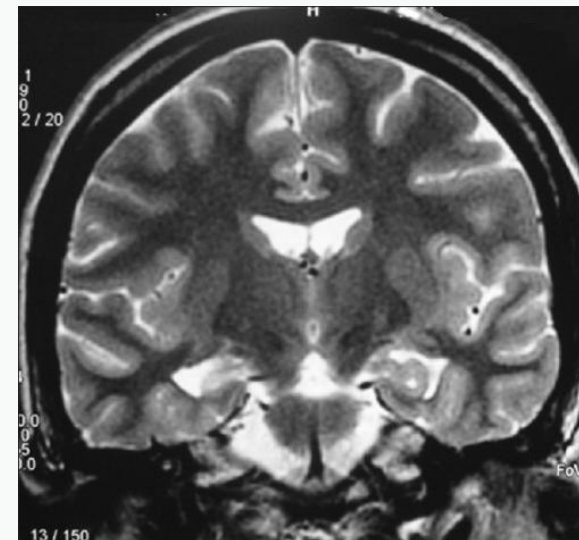


Pense em Alzheimer típico quando o déficit de armazenamento episódico lidera o quadro.

- início insidioso, progressão lenta
- repetição de perguntas, esquecimento de fatos recentes
- reconhecimento também falha quando o armazenamento está comprometido
- desorientação espacial e depois linguagem / praxia

Imagem mais compatível

- atrofia hipocampal/mesial temporal
- padrão temporoparietal
- PET/biomarcador em casos atípicos ou jovens



Clínica primeiro; biomarcador quando muda a conduta

Pistas clínicas: Demência com corpos de Lewy



É a demência que mais “parece delirium sem ser delirium”.

- flutuação cognitiva
- alucinações visuais complexas e bem formadas
- distúrbio comportamental do sono REM
- parkinsonismo espontâneo
- sensibilidade a antipsicóticos e quedas precoces

Padrão cognitivo costuma ser mais atencional-visuoespacial do que amnésico puro.

Dica de prova e de vida real: se o paciente “vê pessoas” + REM + parkinsonismo, DCL sobe muito.

Pistas clínicas: Demência frontotemporal



No paciente mais jovem, comportamento ou linguagem podem preceder memória por anos.

- desinibição, apatia, perda de empatia
- compulsões/rituais, hiperoralidade
- pobre crítica, conduta social inadequada
- afasia progressiva primária nas variantes linguísticas
- memória pode parecer “menos pior” no início

Imagem esperada

- atrofia frontal e/ou temporal anterior
- muitas vezes assimétrica
- FDG-PET ajuda quando RM não resolve

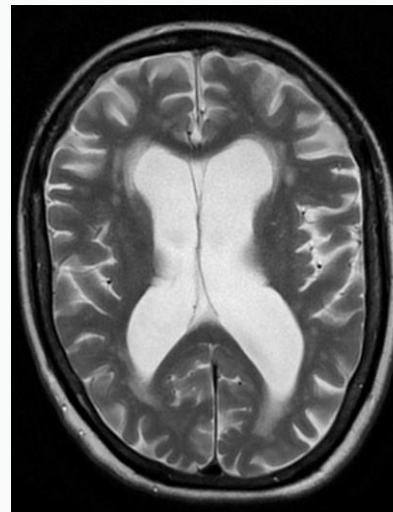
Quando a família diz “ele virou outra pessoa”, pense DFT.

Pistas clínicas: Demência vascular



Não basta ver “microangiopatia” no laudo; é preciso coerência clínico-radiológica.

- início após AVC/AIT ou piora em degraus
- perfil disexecutivo-lento > amnésico puro
- marcha, quedas, sinais focais e pseudobulbar
- fatores de risco vasculares pesados
- infartos estratégicos, lacunas, micro-hemorragias, doença de pequenos vasos



Ponto crítico

- lesão vascular “incidental” não explica todo quadro
- use a temporalidade + fenótipo + imagem

Integração > laudo

Outros diferenciais e red flags



O grande erro é chamar tudo de Alzheimer.

1

HPN

marcha > cognição + urgência urinária

2

Rápida / priônica

semanas–meses, mioclonias, ataxia

3

Autoimune / infecciosa

convulsões, febre, LCR alterado

4

Depressão / apneia / drogas

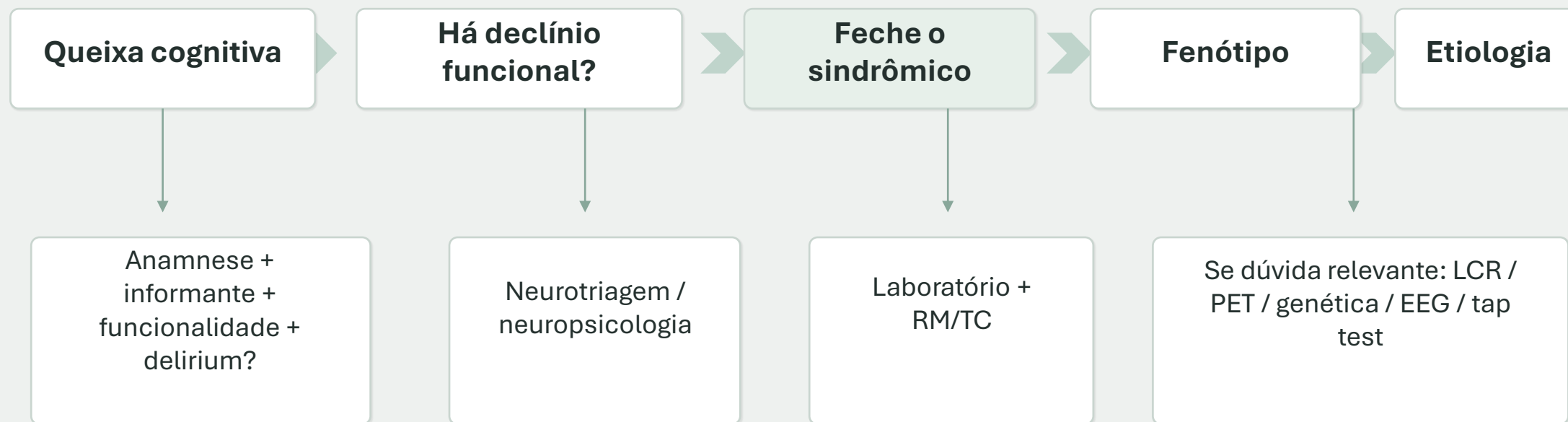
queixa grande, desempenho variável, sonolência,
anticolinérgicos

Se o curso é muito rápido, mude o seu trilho mental imediatamente.

Fluxograma do consultório ao diagnóstico etiológico



Da queixa ao plano: um caminho que cabe no ambulatório.



Discussão ativa: em qual etapa você mais tende a “pular” e perder diagnóstico?

Caso clínico 1

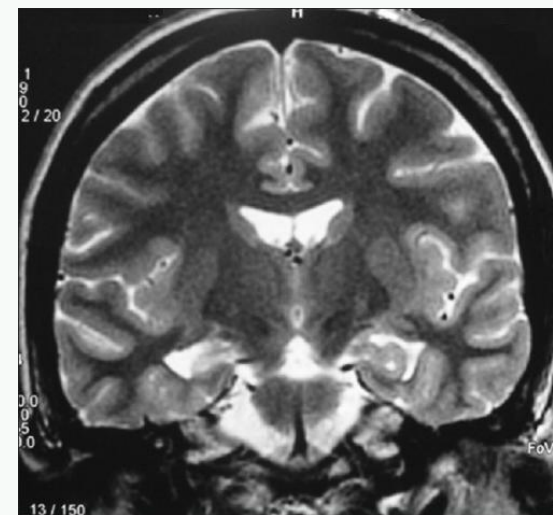
Pense-pareie-compartilhe antes da resposta.



Dona Lúcia, 72 anos, professora aposentada

- 18 meses de repetição de perguntas, perda de contas e dificuldade com receitas novas
- Mantém higiene e marcha preservadas; sem flutuação importante
- MoCA 19/30; TSH, B12 e glicemia normais
- RM: atrofia hipocampal bilateral predominante

Qual é o diagnóstico sindrômico? E qual hipótese nosológica/etiológica é a mais provável?



Dê 60 segundos para o grupo formular em 3 linhas.

Caso 1: resolução comentada



O mais importante é explicitar o raciocínio, não apenas o nome da doença.

1

Sindrômico

demência leve / TNC maior leve

2

Nosológico

provável doença de Alzheimer
típica

3

Etiológico

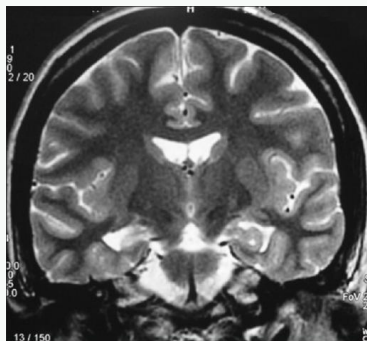
processo neurodegenerativo
compatível com Alzheimer; sem
causa alternativa dominante

Conduta inicial: AChEI + orientação familiar + revisão de segurança/finanças + atividade física/reabilitação.

Neuroimagem: padrões que ajudam no diferencial

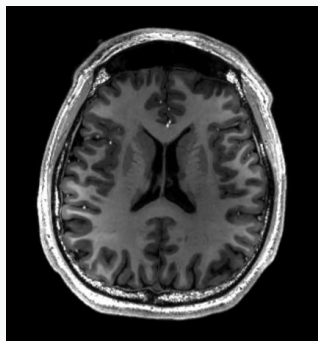


Imagem apoia plausibilidade etiológica; não substitui a clínica.



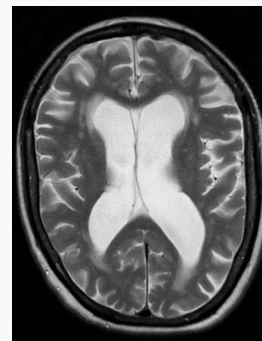
Alzheimer

hipocampo /
temporoparietal



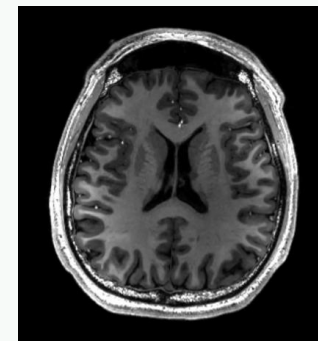
DCL

menos específica; pense
DAT/FDG-PET



DFT

frontal e temporal anterior



Vascular

lacunas, infartos
estratégicos, leucoaraiose

Sempre correlacione a topografia da imagem com o padrão cognitivo observado.

Biomarcadores: quando eles entram?



Use quando aumentarem a certeza diagnóstica ou mudarem tratamento/prognóstico.

Considere mais fortemente em:

- início precoce / pré-geriátrico
- apresentação atípica
- dúvida real entre etiologias
- elegibilidade para terapias específicas
- necessidade de maior segurança prognóstica

Ferramentas

- LCR: A β 42/A β 40, tau total, p-tau
- PET amiloide/tau em centros especializados
- biomarcadores sanguíneos: promissores, mas dependem de contexto clínico e disponibilidade

Biomarcador não substitui fenótipo clínico.

Tratamento: princípios gerais



O objetivo não é só “melhorar teste”; é preservar função, segurança e vida significativa.

Sintomático

alivia sintomas cognitivos
ou comportamentais

Disease-modifying

em cenário selecionado,
pode retardar progressão

Não farmacológico

reabilitação, exercício,
ambiente, educação

Multidisciplinar

médico, fisio, TO, fono,
psico, cuidador

Pergunta terapêutica certa: “o que mais melhora o desfecho que importa para esta família?”

Inibidores da acetilcolinesterase (IAChE)



O que está disponível no mercado brasileiro e quando pensar em usar.

Fármaco	Uso típico	Dose inicial	Observações
Donepezila	DA leve–grave	5 mg/noite	simples; vigiar bradicardia, síncope
Galantamina LP	DA leve–moderada	8 mg/dia	titulável; GI e adesão
Rivastigmina oral	DA leve–moderada / Lewy	3 mg/dia	GI maior; dividir doses
Rivastigmina adesivo	DA / Lewy / Parkinson-demência	5 cm ²	útil se intolerância GI / fragilidade

- melhor evidência sintomática em DA leve–moderada
- também úteis em DCL e Parkinson-demência
- não suspenda só pela gravidade se ainda houver objetivo clínico

Troca costuma ser por intolerância mais do que por “falha”.

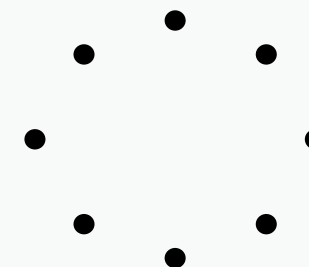
Memantina

Pequeno benefício sintomático; entra melhor do moderado ao grave.



- antagonista NMDA
- iniciar 5 mg/dia e titular até 20 mg/dia
- considerar em Alzheimer moderado–grave
- pode ser associada a IChE
- ajuste em insuficiência renal importante

Na prática: menos “droga do Alzheimer leve”, mais “droga de progressão funcional”.



Quando eu penso nela?

- perda funcional mais clara
- sintomas moderados
- objetivo de reduzir progressão sintomática
- boa tolerabilidade geral

Outras opções: onde entram e onde não entram



Nem tudo que está disponível tem boa evidência para cognição.

SSRIs / trazodona

depressão, ansiedade ou desinibição/compulsividade em FTD selecionada; não tratam cognição

Antipsicóticos

usar só para risco/agitação refratária; extremo cuidado em DCL

Cannabis medicinal

sem evidência robusta como tratamento cognitivo de base

Neuromodulação

rTMS/tDCS promissoras, ainda adjuvantes e não padrão

Anti-amiloides

donanemabe e lecanemabe: casos iniciais selecionados, biomarcador e monitorização

Reabilitação é o pilar do cuidado



Na vida real, funcionalidade e mobilidade mudam mais a trajetória do que muitos remédios.

O que a evidência sustenta?

- atividade física é recomendação forte para pessoas com demência
- ganhos em marcha, equilíbrio, função, qualidade de vida e sintomas cognitivos globais
- programas 3–4x/semana, 30–45 min, >12 semanas têm melhor suporte
- estratégias multicomponentes e aeróbicas costumam performar melhor



Mensagem para a aula: “reabilitação não é acessório; é tratamento”.

Como prescrever reabilitação na prática



Seja específico: o encaminhamento precisa ter objetivo funcional.

Fisioterapia

marcha, força,
equilíbrio, prevenção
de quedas

Terapia ocupacional

AIVDs, adaptação
ambiental,
estratégias
compensatórias

Fonoaudiologia

linguagem,
deglutição,
comunicação
funcional

Estimulação cognitiva

individual ou em
grupo; metas
realistas

Cuidadores

educação, rotina,
segurança,
sobrecarga, diretivas

Exemplo de prescrição útil: “fisioterapia 2–3x/semana com foco em marcha, dupla tarefa e prevenção de quedas”.

Caso clínico 2: qual plano terapêutico você faria?



Discuta em dupla por 90 segundos.

Homem, 79 anos, com DCL provável

- alucinações visuais, sonolência diurna, REM behavior disorder e lentificação de marcha
- familiares relatam quedas e sensibilidade importante a haloperidol
- AIVDs já comprometidas; humor estável

Quais medicações evitar? Qual IChE preferir? O que você prioriza na reabilitação?



Resposta esperada:
rivastigmina/donepezila + evitar
neurolépticos sempre que
possível + plano intenso de
mobilidade, sono, quedas e
cuidador.

Take-home messages



Se o aluno lembrar destes 6 pontos, a aula cumpriu sua missão.

- Demência é síndrome; o alvo final é fechar nosologia e etiologia.
- Função é a fronteira prática entre CCL e demência.
- O padrão cognitivo orienta o diferencial mais do que o escore isolado.
- RM + laboratório evitam erros e refinam o diagnóstico, mas não substituem clínica.
- IChE e memantina ajudam, porém a magnitude costuma ser modesta.
- Reabilitação, exercício e cuidado multidisciplinar mudam desfechos do mundo real.

Frase final para levar à vida: “investigar bem e reabilitar cedo vale tanto quanto medicar”.

Bibliografia selecionada

Referências centrais para aprofundamento e atualização.



- Jack CR Jr et al. DETeCD-ADRD: clinical practice guideline for evaluating cognitive impairment. *Alzheimer's & Dementia*. 2024.
- Smid J et al. Consenso brasileiro de declínio cognitivo subjetivo, CCL e demência. *Dement Neuropsychol*. 2022.
- Schilling LP et al. Diagnóstico da doença de Alzheimer: recomendações da ABN. *Dement Neuropsychol*. 2022.
- NICE NG97. Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. 2018; surveillance 2025.
- Soderlund KA et al. ACR Appropriateness Criteria® Dementia: 2024 Update. *JACR*. 2025.
- McKeith IG et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: fourth consensus report. *Neurology*. 2017.
- Rascovsky K et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for behavioural variant FTD. *Brain*. 2011.
- Ministério da Saúde/Conitec. PCDT da Doença de Alzheimer. 2025.
- WHO. Non-pharmacological interventions for people living with dementia. Updated 2023/2024.
- National Institute on Aging. Difficulty managing bills may signal early dementia. 2025.